Sujet n°1 : SDD 42 HTA

Spécialité : Cardio-vasculaire

Date : 10/10/2023
Auteur : Ambroise Le Pogam (DES de médecine interne - ECN 2018)
Relecteur(s) : Sébastien Villard (DES de médecine interne - ECN 2023), Anis Elidrissi (DES de cardiologie - ECN 2018

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen clinique - Tensiomètre
Item(s) en lien avec la station	224. Hypertension artérielle
Situation(s) de départ en lien avec la station	42. Hypertension artérielle
Matériel nécessaire à la station	Tensiomètre, stéthoscope
Contexte de la station	Consultation de médecine générale au cabinet

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste en ville.

Vous recevez la patiente Mme. Hacheta Maria en consultation, âgée de 50 ans, au cabinet qui présente une hypertension artérielle à domicile depuis ce matin, recontrôlé à trois reprises avec son propre tensiomètre à 187/95 mmHg, puis 200/105 mmHg et enfin 185/95 mmHG. Elle explique avoir saigné du nez pendant 5 minutes ce matin et que c'est la troisième fois ce mois-ci que surviennent des épisodes similaires d'hypertension et d'épistaxis.

Mme. Hacheta est hypertendue depuis 10 ans, sous bithérapie par Ramipril (Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion) 5 mg et Amlodipine (Inhibiteur Calcique) 5 mg, a une hypercholestérolémie contrôlée sous Atorvastatine 10 mg et une obésité IMC = 34 kg/m2. Elle n'a jamais eu de complication cardio-vasculaire secondaire (notamment pas d'AVC ni d'infarctus). Ses deux parents avaient une obésité, une hypertension et un diabète. Sa dernière prise de sang date d'il y a un mois incluant NFS, ionogramme sanguin (K+, créatinémie), HbA1c et bilan lipidique était strictement normale.

Consignes :

Vous devez réaliser en 7 minutes :
- Interrogatoire sur la cause de l'hypertension mal contrôlée
- Interrogatoire sur les conséquences de l'hypertension mal contrôlée
- Contrôle de la tension au brassard

Vous ne devez pas :
- Faire d'examen clinique
- Proposer une prise en charge thérapeutique ou exploratoire
- Prendre en charge l'épistaxis (tari lors de la consultation)
- Proposer une prise en charge hospitalière
- Attendre 5 minutes de repos/sans avoir parlé pour prendre la tension de la patiente

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Recherche les causes de l'hypertension artérielle non contrôlée : - Tabagisme OU Alcool - Mauvaise observance des traitements - Régime déséquilibré en sel - Absence d'activité physique - Mauvaise prise de tension à domicile (poignet, tensiomètre ancien, pas de repos avant, après café ...) - Iatrogénie/toxique (au moins un cité) : prise de réglisse ou boisson anisé, traitement nasal vasoconstricteur, corticoïdes, AINS, ciclosporine, EPO, cocaïne, amphétamine	1 pt/éléments Maximum 4 points	☐
2.	Demander si la patiente tient un carnet tensionnel ou lui proposer d'en tenir un	1 pt	
3.	Savoir interroger sur le SAOS spécifiquement : - Céphalée matinale - Ronflement (si non évoqué par le patient) - Nycturie - Somnolence diurne (télévision, lecture, repas, en cours de discussion) - Somnolence au volant (spécifiquement)	1 pt/éléments Maximum 3 points	☐
4.	Avoir interrogé sur les conséquences de l'hypertension sévère aiguë et chronique : - Douleur thoracique - Dyspnée - Troubles visuels - Épisodes évocateurs d'AIT/AVC (trouble moteur, sensitif, difficulté à parler)	1 pt/éléments Maximum 3 points	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

	- Claudication à la marche		
5.	Prise de la tension au brassard en ayant respecté 2 des conditions suivantes : - Position allongée - Brassard au bras 1-2 cm au-dessus du pli du coude - Respect de la flèche du brassard en regard de l'artère humérale - Dire à la patiente de ne pas parler	1 pt / éléments Maximum 2 points	☐
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)			

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TOTAL (max 20 items)	**15 points**

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Motif très fréquent de consultation en médecine générale ainsi qu'aux urgences, notamment depuis la démocratisation des appareils d'auto-contrôle tensionnels à domicile (et maintenant saturomètres !).

Rechercher les éléments expliquant une tension mal contrôlée :

- Absence d'activité physique
- Alcool
- Tabac
- Mauvaise observance du traitement
- SAOS
- Hypertension artérielle secondaire (hypercorticisme, sténose des artères rénales, insuffisance rénale chronique, phéocromocytome …)
- Iatrogénie/Toxique : Réglisse, boisson anisé, Cocaïne, Amphétamine, corticoïde, vasoconstricteur nasaux, Ciclosporine, dérivés de l'ergot de seigle, AINS, EPO …

Le Syndrome d'apnée obstructive du sommeil est une cause importante de tension mal contrôlée et d'autant plus à évoquer que l'obésité reste un enjeu de santé publique, et que le SAOS provoque et entretien l'hypertension mal contrôlée, le syndrome métabolique, majore drastiquement le risque d'AVC en plus d'impacter la qualité de vie du patient (céphalée, nycturie, somnolence) et de présenter un risque réel d'endormissement au volant.
Échelle de somnolence d'Epworth >10 encourage à réaliser une polysomnographie ventilatoire du sommeil.

La manière la plus efficace d'avoir un reflet réel de la tension artérielle à domicile est de tenir un carnet tensionnel avec la règle des 3 :

- 3 prises de tension d'affilée (après 5 minutes de repos, idéalement allongé ou assise, sans avoir parlé ni bu de café ni tabac dans l'heure)
- 3 fois dans la journée (matin, midi et soir) le même jour
- 3 jours dans la semaine

Les tensions permettent d'avoir un bon reflet de l'état tensionnel du patient, plutôt que des prises de tension itératives.
L'examen le plus pertinent pour évaluer l'hypertension reste un Holter tensionnel à domicile sur 24H.

L'examen clinique s'attache à chercher une conséquence de l'hypertension sévère aigue et d'une hypertension chronique mal contrôlée :

- Interrogatoire sur douleur thoracique, dyspnée, douleur AOMI, claudication à la marche, épisode d'AIT/AVC, flou visuel (rétinopathie hypertensive)
- Auscultation pulmonaire pour s'assurer l'absence de crépitant/signe d'insuffisance cardiaque chronique

Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

- Auscultation cardiaque pour chercher un rythme régulier, absence de souffle cardiaque, tachycardie
- Palpation des pouls à la recherche d'artériopathie des membres inférieurs : pouls pédieux, poplité ET anévrysme abdominal : palpation abdominale ciblée sur la région de l'artère

Contrôler la tension au cabinet est important pour vérifier un potentiel dysfonctionnement du matériel utilisé à domicile ou d'une mauvaise utilisation du tensiomètre à domicile (si la tension est continuellement normale au cabinet) et sera l'occasion de rappeler les modalités d'utilisation du tensiomètre et de prise de tension, ainsi que d'encourager à réaliser un carnet tensionnel.
Le deuxième intérêt est surtout d'orienter le patient aux urgences en cas de suspicion d'HTA maligne (PAS > 200 mmHg ou PAD > 130 mmHg) pour réaliser un fond d'œil à la recherche de rétinopathie sévère et d'autres conséquences de l'hypertension maligne.
Néanmoins en cas de tension élevée en cabinet mais non menaçant, on ne peut tirer de conclusion sur l'état de l'hypertension chronique du patient, la prise de tension au cabinet pouvant être faussé par l'effet « blouse blanche », la valeur au domicile si bien prise est plus informative (encourager au carnet tensionnel !).

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

La patiente a présenté une pression artérielle élevée à domicile en surveillant sa tension. Elle vient en consultation car elle est inquiète et que cela fait plusieurs fois ce mois-ci que sa tension artérielle est mal contrôlée.

Plan de la station ECOS :

Le patient commence la consultation en face de l'étudiant devant un bureau ou deux chaises face à face.
A la fin de l'interrogatoire l'étudiant lui propose de s'allonger sur une table pour réaliser l'examen clinique et la prise de tension artérielle.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

« Bonjour Docteur, cela fait un mois qu'à chaque fois que je prends ma tension elle est très élevée, au-dessus de 18/9 et que des fois je saigne du nez. Ça m'inquiète et je ne comprends pas pourquoi. »

Identité du patient :

Mme. Hacheta Maria 50 ans idéalement obèse (sinon dire à l'étudiant que la patiente est obèse), 1m60 - 92 kg.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Mode de vie :

Bibliothécaire, mariée, 2 enfants 16 et 18 ans, pas d'animaux (inutile pour la consultation).
Pas de tabagisme actif ni d'antécédent de tabagisme, pas de prise d'alcool quotidien, pas d'allergie aux médicaments.
Prend sa tension régulièrement pour surveiller.
Fait attention à ce qu'elle consomme, ne sale pas les plats en plus, cuisine un maximum.
Sédentaire au travail et une fois à la maison. Prise de poids depuis plusieurs années.

Comportement global :

Légèrement inquiète car tension mal contrôlée depuis un mois alors qu'elle prend ses traitements.
Comportement sinon « normal », ne coupe pas la parole, réponds simplement aux questions de l'étudiant.

Antécédents personnels :

Hypertension artérielle sous bithérapie.
Hypercholestérolémie sous statine.
Obésité 34 kg/m2 IMC ancien.
Pas d'activité physique, travaille toujours et sédentaire.
Pas de complication cardio-vasculaire secondaire.
Observance parfaite au traitement : prend bien tous les jours sans oublier de prise, a un pilulier.

Antécédents familiaux :

Les deux parents diabétiques, obèses, hypertendus. Père décédé infarctus 75 ans, mère en vie. Pas de frère et sœurs. Enfants en bonne santé.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Médicaments :

Bien distinguer le traitement de fond (= habituels) des traitements pris récemment dans le cadre de la situation clinique (ex prise de PARACETAMOL pour soulager les douleurs)

Ramipril 5 mg, Amlodipine 5 mg, Atorvastatine 10 mg au long cours.
Aucune auto-médication ou médecine alternative, pas de traitement pris récemment notamment en réaction à l'hypertension.

Symptômes positifs :

Répondre à la négative pour alcool, tabac, inobservance médicamenteuse (« je prends tous les jours, je fais attention, j'ai un pilulier … »), régime contrôlé en sel (« je fais attention, je ne sale pas les plats, je cuisine moi-même »).

Répondre à la négative pour tous les signes de complications de l'hypertension en aigue (douleur thoracique, difficulté à respirer, troubles moteurs/sensitif/dysphasie évocateurs d'AIT/AVC) ainsi qu'en chronique (douleur thoracique, dyspnée, claudication, pas de troubles visuels)

Répondre positivement SI DEMANDÉ (ne pas évoquer spontanément) pour :

- Sédentarité, pas d'activité physique, prise de poids depuis plusieurs années
- Ronflement « mon mari s'en plaint tous les jours »
- Nycturie (« je me lève au moins 2 fois toutes les nuits pour aller aux toilettes »)
- Somnolence diurne « je m'endort devant un livre, devant la télé, au travail, et même des fois au volant » ou « je m'endort partout en journée, je pense que j'ai un mauvais sommeil »
- Céphalée/maux de tête le matin au réveil

Au moment de la prise de tension, se mettre à parler (discussion banale au choix de l'acteur/patient).

Constantes :

Pas d'intérêt pour ce cas.
Mais si jamais, patiente complètement asymptomatique et FR : 14/min, Sat02 98%, Fc : 70 bpm, douleur EVA 0/10.

Lorsque l'étudiant prendra votre tension : Annoncer "185/90 mm Hg".

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Donnée complémentaire :

Aucune

Questions de relance :

Après 4 minutes au timer ou si l'étudiant ne pose plus de question ou n'a pas demandé pour le syndrome d'apnée du sommeil avant de passer à la prise de tension, dire en rigolant « Ah aussi, je sais pas si ça a un rapport mais mari arrête pas de dire que je ronfle beaucoup … mais bon ça l'empêche pas de dormir».

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

« Ambiance » consultation de médecine générale, le patient se place d'un côté du bureau et l'étudiant de l'autre pour débuter l'interrogatoire, puis possibilité d'allonger le patient pour l'examen clinique et la prise de tension sur une table à examiner/un lit présent dans la pièce.

Matériel nécessaire à la station :

- Tensiomètre automatique pour l'étudiant
- Lit pour allonger le patient pour la prise de tension
- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)